

Fecha Última Actualización: 31-08-2022 18:58:10

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Fernando Patricio Plaza Cortez	Rut : 5.133.392-6	N° Archivo : 0624487	N° Epicrisis
Edad : 79a 3m 8d	Fecha Nacto : 23/05/1943	Sexo : Masculino	321357
Dirección : Pasaje Baturro 0589 Villa La Primavera	Comuna : Puente Alto	Teléfono : 9 2018 7371	

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto	Fecha Ingreso : 27/07/2022	18:23	Días Estadía : 35
Unidad de Egreso : Utim (5to Piso Mater)	Fecha Egreso : 31/08/2022	18:08	

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Fernando Patricio Plaza Cortes.
EDAD: 79 años
RUT: 5133392-6
FI HSR: 27/07/22
FI UPC: 28/07/22

ANTECEDENTES

- Mórbidos: DM2NIR, HTA.
- Fármacos: Losartán, Metformina, Glibenclamida.
- Quirúrgicos: cirugía traumatológica cadera.
- Alergias: Penicilina dudosa.
- Hábitos: no descritos.
- Inmunizaciones: COVID-19 4 dosis, Influenza hasta 2021, Neumococo 2016.
- Social: aparentemente autovalente.

Anamnesis próxima

Paciente con antecedentes descritos ingresa por cuadro de 4 días de evolución de compromiso del estado general, anorexia, asociado a vómitos sin elementos patológicos, mialgias, diarrea, dolor abdominal generalizado y compromiso cuantitativo de conciencia. Niega historia de fiebre, calofríos ni síntomas respiratorios. Ingres a REA CASR en malas condiciones generales, taquicárdico, hipertenso, mal perfundido, con livideces en muslos y enlentecimiento del llene capilar, con mala mecánica ventilatoria y uso de musculatura accesoria, en sopor profundo. Se solicita HGT que resulta Hi, con ECG que impresiona en RS pero con SDST pared inferolateral. Se realiza Ecoscopia bedside que muestra corazón hiperdinámico, sin líneas B significativas, sin derrame pericárdico, VCI no pletórica.

Se enfrenta inicialmente como shock cardiogénico, se solicitan exámenes dentro de los que destacan: Lactato 73 Hb 12.8 PCR 467 GB 10260 PLT 89k Crea 3.98 BUN 72 Na 149 AU 10.3 cuerpos cetónicos (+) en orina. Se solicita evaluación por UCO, se activa hemodinamia de urgencia, se realiza coronariografía que muestra estenosis crítica de arteria circunfleja, con instalación de DES, ventriculografía de salida FEVI > 50%. Evolucion a shock mixto (séptico y cardiogénico) profundo, con requerimientos de noradrenalina y adrenalina en dosis altas. Dado la presencia de cuerpos cetónicos en orina, se inicia manejo con BIC de insulina. Se rescata HC I y II (+) CGP en cadenas, con panel molecular (+) para S. agalactiae más E. coli, sin identificar genes de resistencia.

Fecha Epicrisis : 31/08/2022 18:58

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 31-08-2022 18:58:10

Página 2 de 3

Se traslada a UPC para continuar manejo.

Diagnósticos de ingreso

Shock mixto (cardiogénico y séptico) - Falla orgánica múltiple.

IAM c/SDST. DES a arteria circunfleja (28/07/22).

Bacteriemia por *S. agalactiae* y *E. coli*.

Cetoacidosis diabética.

AKI KDIGO III.

Evolución durante hospitalización

Hemodinamia: Ingresa con shock indiferenciado con sospecha de shock séptico y cardiogénico (IAM con SDST con DES a la arteria circunfleja, se mantiene DAPT y atorvastatina) con requerimientos de drogas vasoactivas en dosis altas. Dado posible insuficiencia suprarrenal se indica hidrocortisona en dosis de estrés por 3 días. Logra destete de drogas vasoactivas. Dado taquicardia persistente se solicita AngioTAC (06/08) que descarta TEP.

Cardiológico: IAM c/SDST reperfundido el 27/07 con DES en arteria circunfleja. Mantiene medidas de prevención secundaria.

Ventilatorio: VMI con parámetros protectores. Weaning dificultoso por estado de conciencia y hemodinamia, por lo que se realiza TQT el 19/08/22. Desde el 22/08 se mantiene con filtro con requerimientos bajos de oxígeno, con imagen de control con derrame pleural leve-moderado.

Últimas 48 horas, tras salir de UCI, paciente con evolución tórpida, falla respiratoria severa con uso de musculatura accesoria. Equipo de UCI define no volver a conectar a ventilación mecánica, de acuerdo. Dado larga estadía hospitalaria, interurrencias clínicas y miopatía del paciente crítico se decide no volver a conectar a ventilación mecánica. Se procede a manejo paliativo de dolor y disnea con fentanilo.

Infeccioso: Ingresa por bacteriemia por *S. agalactiae* MS más *E. coli* MS, se inicia tratamiento con Ceftriaxona y Clindamicina. Se solicita estudio con TAC TAP sin evidencia de foco. Dado aumento de volumen en rodilla derecha se realiza artrocentesis sugerente de artritis séptica, se realiza aseo quirúrgico de rodilla derecha el 31/07 con cultivo (-). El 31/07 presenta aumento de falla multiorgánica y elevación de parámetros inflamatorios, por lo que se decide escalar antibioterapia a meropenem y vancomicina. Evoluciona de forma tórpida por lo que el 06/08 se realiza nueva artrocentesis que descarta artritis séptica y se solicita TAC TAP (06/08) sin evidenciar nueva foco infeccioso. El 09/08 se cambia esquema antibiótico a ceftriaxona evaluado con infectología dado ausencia de resistencia en cultivos. El 18/08 se inicia imipenem y vancomicina dado persistencia de parámetros inflamatorios elevados. En examen físico destaca celulitis en relación a EEII derecha, por lo que se conversa con infectología quien sugiere cambio de esquema a imipenem y linezolid el 22/08 y se solicita TAC de EEII y en zona pélvica presenta eritema y edema, sin evidencia de foco. Además dado UC (+) para *Candida albicans* con score *Candida* de alto riesgo se inicia fluconazol. Cultivo de aspirado traqueal 18/08 (+) *Candida albicans* y lesiones genitales sugerentes de candidiasis. Evolución desfavorable, persistentemente febril, se decide no escalar en antibióticos dado limitación en soporte ventilatorio.

Cutáneo: Con gangrena seca de 1° y 2° ortijos de ambos pies más lesiones violáceas en ambas piernas secundario al uso de DVA a dosis altas. Sin signos de infección.

Gastrointestinal: Evoluciona con alteración de pruebas hepáticas con patrón mixto que se interpreta en contexto de DILI vs sepsis. Evoluciona con disminución progresiva de pruebas hepáticas.

Hematológico: Caída progresiva de Hb que requiere de transfusión. Se evidencia sangrado orofaríngeo en relación a TOT el 16/08 con manejo local, sin evidencia de otra exteriorización de sagrado. Durante la hospitalización con requerimiento de múltiples transfusiones de glóbulos rojos.

Metabólico/Nutricional: CAD severa resuelta el 31/07, se mantiene con BIC de insulina. Posterior a resolución inicia alimentación enteral manteniéndose en vigilancia parámetros de síndrome de realimentación, sin alteración.

Nefrológico: con AKI KDIGO III, se desconocen antecedentes de disfunción renal. Inicia TRR con UFA inicialmente diario. El 22/08 evoluciona anúrico, se coloca sonda foley por urología dado lesión en meato urinario, logrando diuresis. Última diálisis fue el 29/08. Se decide no seguir dializándose dado la mala evolución clínica.

Fecha Epicrisis : 31/08/2022 18:58

Página 2 de 3

Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



Fecha Última Actualización: 31-08-2022 18:58:10

Página 3 de 3

Paciente con mala evolución clínica, con deterioro severo en últimas 48 horas tras salida de UCI, con insuficiencia respiratoria aguda severa, uso de musculatura accesoria y sopor superficial. En contexto de larga estadía hospitalaria en UCI, edad, fragilidad, interurrencias médicas y miopatía del paciente crítico, se define por equipo médico de UCI y de UTIM no conectar nuevamente a ventilación mecánica y manejo paliativo de disnea y dolor.

Paciente fallece el día 31.08.22 a las 14:41 horas. Esposa al tanto de la gravedad del paciente, aviso sobre fallecimiento. Realizo certificado de defunción y entrego a esposa e hijo.

Diagnóstico de Egreso

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA -
ARTRITIS PIOGENA - Artritis séptica de rodilla
OTRAS MIOPATIAS - Miopatía del paciente crítico.

Condición de Egreso Fallecido

Egreso con Catéter Doble J:NO

Detalle en epicrisis.

Plan Post Alta

No aplica.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Alfonso Briones Arecheta
Médico Tratante (Staff)